SDD 128 Sujet n°1

Spécialité : Neurologie

Date : 31/08/2024
Auteur : Gaëlle Tisserand - EDN 2024
Relecteur(s) :

Domaine d'apprentissage principal	Annonce/information au patient
Domaine d'apprentissage secondaire	Education/prévention
Item(s) en lien avec la station	106. Maladie de Parkinson 107. Mouvements anormaux
Situation(s) de départ en lien avec la station	128. Tremblements 126. Mouvements anormaux
Matériel nécessaire à la station	3 chaises - 1 table - papier de brouillon - stylos - iPad pour examinateurs
Contexte de la station	Consultation d'annonce de maladie de Parkinson

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes un.e médecin généraliste.
Vous recevez Mr Robert, âgé de 73 ans au cabinet pour des tremblements de repos depuis plusieurs mois.

A l'examen clinique vous constatez effectivement un tremblement de repos aggravé par le calcul mental, une perte du ballant des bras, et une roue dentée.

Vous ne retrouvez pas de signes corticaux, de syndrome cérébelleux, de syndrome pyramidal, d'hypotension orthostatique, de troubles oculomoteurs, de chute, de syndrome pseudo-bulbaire : dysarthrie, troubles de la déglutition précoces, pas d'hallucination et pas de trouble cognitif.

Consignes :
Vous devez en 8 minutes :

- Annoncer au patient le diagnostic que vous suspectez
- Expliquer au patient le pronostic et l'évolution de la maladie
- Proposer une prise en charge thérapeutique (médicamenteuse ET non médicamenteuse) de première intention

Vous ne devez pas :

- Revenir sur l'examen clinique
- Evoquer les diagnostics différentiels
- Rédiger d'ordonnance

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	Annonce une maladie de Parkinson	1 point	☐
2.	Explique au patient qu'il s'agit d'une maladie dégénérative incurable, on peut seulement la ralentir	1 point	☐
3.	Explique les différentes phases de la maladie : 1 : Lune de miel : symptômes totalement contrôlés sous traitement	1 point	☐
4.	2 : Complications motrices de la L-DOPA : dyskinésie au pic de dose, akinésie de fin de dose, effet ON-OFF	1 point	☐
5.	3 : Déclin moteur et cognitif : freezing, camptocormie, démence, troubles vésicosphinctériens, hypotension orthostatique, troubles posturaux, chutes	1 point	☐
6.	Propose une thérapeutique médicamenteuse par LévoDOPA ***Pas de point si propose un agoniste dopaminergique***	1 point	☐
7.	Propose une prise en charge par kinésithérapie +/- orthophonie	1 point	☐
8.	Incite le patient à faire de l'activité physique	1 point	☐
9.	Propose la mise en ALD 30 pour une prise en charge à 100%	1 point	☐
10.	Informe le patient de l'existence d'association de patient ET/OU propose un soutien psychologique	1 point	☐
11.	Propose la mise en place d'aides à domicile	1 point	☐
12.	Propose de le revoir en consultation pour évaluer l'efficacité du traitement et répondre à ses questions	1 point	☐
	Bonus : recherche une exposition aux pesticides pour déclaration maladie professionnelle	1 point	☐

Communications et attitudes

13.

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

14.

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

15.

11. APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS (= approche centrée sur le patient)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Le projet des soins ne correspond pas au tableau clinique ou ne prend pas en compte le patient et ses besoins	Le projet des soins est adapté au tableau clinique Omet quelque fois de prendre en compte les capacités / contraintes du patient	Fait participer le patient à la planification de ses soins *(ex invite le patient à poser des questions)*	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient.	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient. Renforce la confiance du patient et son autonomie

16.

1. Échelle d'évaluation de performance globale: description générale

Performance Insuffisante *Clear fail*	**Performance Limite** *Borderline*	**Performance Satisfaisante** *Clear pass*	**Performance Très Satisfaisante** *Very good pass*	**Performance Remarquable** *Excellent pass*
Très au-dessous des attentes	Performance proche mais en dessous des attentes	**Conforme aux attentes**	**Au-delà des attentes**	**Très au-delà des attentes**
Les attentes sont non observables ou non respectées Présente un niveau inacceptable de connaissances ou de performance	Les omissions et les inexactitudes dans la réalisation des tâches Démontre du potentiel pour atteindre la compétence	Démontre les éléments essentiels de la performance Prêt pour avancer en toute sécurité	Quelques omissions/erreurs mineures et non essentielles Démontre la plupart des aspects de la compétence	Agit sans hésitation et sans erreur Démontre la maîtrise de tous les aspects de la compétence

TOTAL	**…/16 points**

Bonus : Vidéo du CEN sur l'interrogatoire d'un patient avec tremblements : https://www.cen-neurologie.fr/videotheque/tremblement-parkinsonien

Éléments de rétroaction :
Station d'annonce de maladie, il y a donc un poids plus important des échelles de performances communication.
Pour annoncer au patient il faut tâter le terrain : est-ce qu'il se doute qu'il a une maladie, si oui laquelle, est-ce qu'il a déjà entendu parler de la maladie de parkinson ?
Une fois que le diagnostic est posé, laisser au patient le temps de digérer et poser ses questions. Ne pas hésiter à reformuler pour s'assurer de la compréhension du patient et proposer une deuxième consultation pour poser ses questions.

Ici on excluait tous les drapeaux rouges des maladies Parkinson + en gros, tout ce qui n'est pas un syndrome extra-pyramidal pur. Il n'était donc pas nécessaire de réaliser un DAT Scan pour poser le diagnostic.

Concernant la prise en charge médicamenteuse :
Avant 65-70 ans :

- Agoniste dopaminergique LP en monothérapie (retardement de l'apparition des complications motrices) ou inhibiteur de la monoamine oxydase B (IMAO-B). Ces deux thérapeutiques peuvent être associées. En cas d'antécédent d'addiction, la prescription des agonistes dopaminergiques doit être évaluée avec beaucoup de prudence (risque potentiel de troubles du contrôle des impulsions).
- Si contrôle insatisfaisant, progression posologique de l'agoniste dopaminergique. Si contrôle insatisfaisant ou mauvaise tolérance, association avec la L-dopa ou IMAO-B
- Possibilité de débuter d'emblée le traitement par la L-dopa avec inhibiteur de la DDC, en cas de handicap moteur et d'altération de la qualité de vie qui doivent être évalués au cas par cas. Proposer progressivement 3 à 4 prises par jours (car ½ vie courte) avant les repas pour faciliter l'absorption et l'efficacité.
- En cas de nausées ou de vomissements (nausées, vomissements), un traitement par dompéridone peut être prescrit (diminution des effets secondaires à la stimulation des récepteurs dopaminergiques périphériques ; contre-indication en cas d'allongement du temps QTc) en limitant la prescription à la durée de traitement la plus courte (usuellement 7 jours maximum).
- Anticholinergiques : Moins prescrits en raison de leurs effets secondaires, ils peuvent avoir un intérêt chez les patients jeunes avec tremblement malgré un traitement dopaminergique bien conduit.

Après 65-70 ans

- L-dopa avec inhibiteur de la dopa décarboxylase d'emblée en monothérapie ou IMAO-B.
- Si contrôle insatisfaisant, progression posologique de la L-dopa ou association avec IMAO-B.

- Coprescription de domperidone (contre-indication en cas d'allongement du temps QTc)

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

<u>Contexte</u> :
Vous êtes un.e médecin généraliste.
Vous recevez Mr Robert, âgé de 73 ans au cabinet pour des tremblements de repos depuis plusieurs mois.

A l'examen clinique vous constatez effectivement un tremblement de repos aggravé par le calcul mental, une perte du ballant des bras, et une roue dentée.

Vous ne retrouvez pas de signes corticaux, de syndrome cérébelleux, de syndrome pyramidal, d'hypotension orthostatique, de troubles oculomoteurs, de chute, de syndrome pseudo-bulbaire : dysarthrie, troubles de la déglutition précoces, pas d'hallucination et pas de trouble cognitif.

<u>Consignes</u> :
Vous devez en 8 minutes :

- Annoncer au patient le diagnostic que vous suspectez
- Expliquer au patient le pronostic et l'évolution de la maladie
- Proposer une prise en charge thérapeutique (médicamenteuse ET non médicamenteuse) de première intention

Plan de la station ECOS :

Le patient est assis face au candidat, séparé par une table.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

Alors docteur, que pensez-vous de mes tremblements ?

Identité du patient :

Mr Rorbert, 73 ans, 1m75, 65 kg, IMC 21.2

Mode de vie :

Ancien agriculteur à la retraite, vit seul, sans enfant, sans aide à domicile, marche sans canne/déambulateur. Loisir : jardinage et bricolage. Alcool occasionnel, vin rouge au repas de famille et une bière de temps en temps. A fumé la pipe pendant des années mais a arrêté depuis plus de 20 ans.

Comportement global :

Vous avez la main droite qui tremble lentement au repos, mais pas dans les mouvements volontaires. https://www.youtube.com/watch?v=H-LaChcsXCQ
Vous ne connaissez pas la maladie de Parkinson et vous êtes attentif aux explications données. Vous êtes choqué du diagnostic mais souhaitez connaître tous les tenants et aboutissants.

Antécédents personnels :

Hypertension artérielle, arthrose hanche droite et genou droit

Antécédents familiaux :

Aucun des deux parents n'a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson ou d'autres troubles neurodégénératifs.
Père : Décédé à 78 ans d'un infarctus du myocarde.
Mère : Décédée à 85 ans, d'une insuffisance cardiaque.

Médicaments :

Ramipril 5mg 1 comprimé matin
Ibuprofène en cas de poussée d'arthrose

Symptômes positifs :

Vous avez un tremblement de repos :
https://www.youtube.com/watch?v=H-LaChcsXCQ

Vous n'avez pas de douleur, et vos tremblements ne vous limitent pas dans vos activités du quotidien, mais vous êtes gênés quand vous voyez vos amis (gêne sociale).
Si le médecin vous propose des aides à domicile, vous refusez l'infirmière à domicile, mais acceptez volontiers une aide ménagère.

Questions de relance :

Si l'étudiant ne vous explique pas les phases de la maladie : « Mais alors avec les médicaments je ne serai jamais malade ? » S'il évoque des complications mais sans expliquer lesquelles « Qu'est-ce qui va m'arriver exactement ? »
Si l'étudiant n'évoque pas la phase de lune de miel où les symptômes sont contrôlés « A quoi ça sert alors de me soigner si de toute façon ça va aller mal ? »
Si l'étudiant ne vous propose pas de médicament « Est-ce que il y a un médicament à prendre ? »
Si l'étudiant ne propose rien d'autre que le médicament demander « Et moi qu'est-ce que je peux faire à part prendre le médicament ? »

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Le patient est face à l'étudiant·e, un bureau séparant les deux personnes.

Matériel nécessaire à la station :

- *IPAD pour examinateur*
- *Feuille de brouillon pour candidat*
- *Stylo pour candidat*
- *Feuille de brouillon pour évaluateur*
- *Stylo pour évaluateur*

Documents présents dans la station :

- *Feuilles d'évaluation de papier de secours*